

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE ALCOHOL (AUDIT)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Detección Precoz de Consumo de Riesgo, Daño Perjudicial y Dependencia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT).
Nombre Original (Inglés)	<i>The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)</i>
Autores del Diseño Original	Drs. Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle, John B. Saunders y Maristela G. Monteiro (1989, 2001) para la Organización Mundial de la Salud (OMS / WHO).
Adaptación al Español	Drs. Juan Carlos Contel, Antoni Gual y Joan Colom (1999, 2001); validado por Rubio et al. (1998).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Detección temprana en atención primaria, urgencias y salud mental.
Tipo de Instrumento	Cuestionario estructurado de 10 ítems (puntuación 0 a 4) autoadministrado o aplicado en entrevista clínica.
Población Diana y Rango	Adolescentes y adultos (a partir de 14-16 años). Población general, clínica ambulatoria y medicina laboral.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en formato autoinforme o cribado breve asistido.
Régimen de Licencia	Dominio público internacional y abierto (OMS). Libre uso clínico e investigativo no comercial.

2. MARCO TEÓRICO Y MODELO DE SALUD PÚBLICA DE LA OMS

El AUDIT fue diseñado por iniciativa de la OMS tras un proyecto colaborativo multinacional en 6 países (Noruega, Australia, EE. UU., México, Bulgaria y Reino Unido). A diferencia de los instrumentos tradicionales (como el MAST o el CAGE), concebidos exclusivamente para identificar alcoholismo crónico o dependencia grave ya establecida, el AUDIT se fundamenta en un **paradigma preventivo de salud pública**.

El modelo asume que el mayor volumen de morbilidad, costes sanitarios y problemas psicosociales atribuibles al alcohol en la comunidad no se concentra en personas con dependencia terminal, sino en el amplio estrato de bebedores con **consumo de riesgo** o **consumo perjudicial** aún no dependientes. El AUDIT permite intervenir precozmente antes de que se consolide el daño orgánico irreversible o la dependencia fisiológica.

Se define la **Unidad de Bebida Estándar (UBE)** en España como **10 gramos de etanol puro** (equivalente a 1 copa de vino de 100 ml, 1 caña de cerveza de 250-300 ml o medio trago corto de licor destilado de 25 ml).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Clínico
1. Consumo de Riesgo	1, 2 y 3	0 a 12	Frecuencia de consumo habitual, cantidad típica consumida y frecuencia de episodios de consumo intensivo concentrado (<i>binge drinking</i> $\geq$ 5 o 6 UBEs en una sola ocasión).
2. Síntomas de Dependencia	4, 5 y 6	0 a 12	Pérdida de control volitivo para detener el consumo, mayor prioridad del alcohol frente a obligaciones habituales y consumo matutino para alivio de malestar o temblor (<i>eye-opener</i>).
3. Consumo Perjudicial	7, 8, 9 y 10	0 a 16	Sentimientos de culpa o remordimiento tras beber, amnesia alcohólica anterógrada (<i>blackouts</i>), lesiones físicas a uno mismo o a terceros, y preocupación manifiesta de allegados o médicos.
PUNTUACIÓN TOTAL	1 al 10	0 a 40	Índice acumulativo de severidad para la estratificación en 4 zonas de intervención de la OMS.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente confiabilidad global: alfa de Cronbach de 0.86 a 0.90 en estudios de validación en atención primaria española (Contel et al., 1999; Rubio et al., 1998).
Sensibilidad y Especificidad	Sensibilidad diagnóstica del 85% al 93% y especificidad del 89% al 98% para detectar consumo perjudicial y dependencia frente a entrevistas diagnósticas estructuradas (SCID-IV / CIDI).
Validez de Criterio	Correlación robusta y positiva con biomarcadores hepáticos y hematológicos clásicos de ingesta alcohólica: Gamma-Glutamil Transferasa (GGT), Volumen Corpuscular Medio (VCM) y Transferrina Deficiente en Carbohidratos (CDT).
Versión Abreviada (AUDIT-C)	Los 3 primeros ítems de consumo muestran una correlación de $r = 0.88$ con el total, funcionando como herramienta de despistaje ultrarrápido (punto de corte ≥ 4 o 5).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIÓN

Cada ítem se puntúa de 0 a 4 puntos de forma ordinal:

- **Ítems 1 a 8:** Disponen de 5 opciones graduadas (0, 1, 2, 3 o 4 puntos).
- **Ítems 9 y 10:** Disponen de 3 opciones: **0** = No; **2** = Sí, pero no en el último año; **4** = Sí, en el último año.
- **Regla de Salto (Skip Pattern):** Si el evaluado responde **0 (“Nunca”)** en el Ítem 1, se puede saltar directamente a los ítems 9 y 10 para descartar antecedentes históricos de daño o consejo médico.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA: LAS 4 ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LA OMS

Zona OMS	Puntos	Nivel de Riesgo Clínico	Intervención Terapéutica Recomendada
Zona I	0 a 7	Bajo riesgo o abstinencia	Educación sobre el alcohol, desmitificación y refuerzo positivo de los hábitos saludables.
Zona II	8 a 15	Consumo de riesgo	Consejo médico simple, material de autoayuda y educación sobre límites de seguridad en UBEs.
Zona III	16 a 19	Consumo perjudicial	Consejo estructurado, Intervención Breve (modelo FRAMES) y monitorización continua en consultas sucesivas.
Zona IV	20 a 40	Sospecha fundada de dependencia	Derivación preferente a servicio especializado en adicciones (CAD / CAS / UCA), evaluación médica integral y posible desintoxicación.

AJUSTE POR GÉNERO Y EDAD: En mujeres, personas mayores de 65 años y adolescentes, la OMS y las guías clínicas españolas recomiendan reducir el punto de corte para consumo de riesgo a ≥ 6 puntos (debido a menor volumen de agua corporal, menor masa hepática y menor actividad gástrica de alcohol deshidrogenasa).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BREVE: EL MODELO FRAMES DE LA OMS

ELEMENTOS CLAVE DE LA INTERVENCIÓN BREVE (5 A 15 MINUTOS):

• **Feedback (Devolución):** Explicar con claridad el resultado en el AUDIT, situando el nivel de consumo en comparación con las medias poblacionales y alertando sobre sus riesgos biomédicos (presión arterial, esteatosis hepática, sueño). • **Responsibility (Responsabilidad):** Destacar explícitamente que la decisión y control del cambio recaen por entero en el paciente: “*Usted es quien decide qué desea hacer con su forma de beber*”. • **Advice (Consejo claro):** Proporcionar una recomendación médica explícita, inequívoca y no ambigua de reducir o suprimir el consumo de alcohol. • **Menu (Menú de opciones):** Ofrecer alternativas prácticas (fijar días fijos semanales sin alcohol, alternar bebidas alcohólicas con agua, evitar rondas colectivas, controlar la velocidad de ingesta). • **Empathy (Empatía):** Mantener una actitud comprensiva, cálida, sin confrontación ni moralización (estilo de entrevista motivacional). • **Self-efficacy (Autoeficacia):** Fortalecer la confianza y el optimismo del paciente respecto a su capacidad real para alcanzar los objetivos pactados.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paciente: Varón de 43 años que consulta para revisión rutinaria de hipertensión arterial esencial mal controlada pese a triple terapia antihipertensiva. Asintomático aparente; niega tener problemas con la bebida. **Puntuación AUDIT Total: 17 puntos (Zona III: Consumo Perjudicial).** • **Dominio 1 (Consumo):** 9 puntos (bebe 4 o más veces por semana, 5 a 6 cervezas al día y episodios de 8 UBEs los fines de semana). • **Dominio 2 (Dependencia):** 3 puntos (en ocasiones le cuesta parar tras la primera consumición; no bebe por la mañana). • **Dominio 3 (Daño):** 5 puntos (sentimiento matutino de culpa ocasional y su pareja le ha pedido insistentemente que reduzca la ingesta). **Conducta Asistencial:** Se realiza devolución estructurada (FRAMES): se vincula directamente su hipertensión refractaria con el consumo diario de alcohol. Se negocia un objetivo de reducción a un máximo de 2 UBEs al día con 3 días consecutivos libres de alcohol por semana. En el control a las 6 semanas, el paciente redujo el consumo a 8 UBEs/semana; la presión arterial descendió a 128/82 mmHg y su puntuación de re-test en el AUDIT bajó a 7 puntos (Zona I).

9. ALERTAS CLÍNICAS Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN MÉDICA URGENTE

ALERTA DE ABSTINENCIA SEVERA:

En Zona IV (≥ 20 puntos) con consumo diario elevado, no recomendar la cesación brusca ambulatoria sin supervisión médica por riesgo de síndrome de abstinencia severo, convulsiones o *delirium tremens*.

CRITERIOS DE ABSTINENCIA ABSOLUTA:

Embarazo o lactancia, hepatopatía alcohólica activa, pancreatitis previa, conducción profesional o ingesta concurrente con psicofármacos sedantes/opiáceos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G. (2001). *AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care* (2nd ed.). World Health Organization.
2. Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., de la Fuente, J. R., & Grant, M. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). *Addiction*, 88(6), 791–804.
3. Contel, J. C., Gual, A., & Colom, J. (1999). Test para la identificación de trastornos por uso de alcohol (AUDIT): Traducción y validación del AUDIT al catalán y castellano. *Adicciones*, 11(4), 337–347.
4. Rubio, G., Bermejo, J., Caballero, M. C., & Santo-Domingo, J. (1998). Validación de la prueba para la identificación de trastornos por el uso de alcohol (AUDIT) en atención primaria. *Revista Clínica Española*, 198(1), 11–14.